감기 중·감기 뒤 기침, 이렇게 지켜보세요

감기(Common cold)는 대부분 며칠 안에 좋아지지만, 기침은 몇 주 더 이어질 수 있습니다. 앞면은 감기를 앓는 동안(항생제·수액·다시 진료할 때), 뒷면은 감기 뒤 오래 가는 기침과 숨이 찰 때 어디로 갈지를 정리했습니다.

감기·인후염은 대부분 바이러스 — 항생제로 빨리 낫지 않습니다

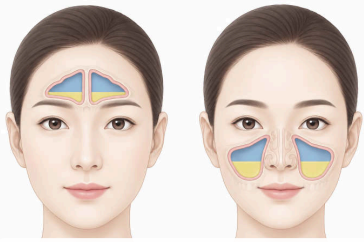
NO BENEFIT
효과가 없습니다
감기에 항생제를 먹어도 더 빨리 낫지 않습니다.

SIDE EFFECTS
부작용은 생깁니다
필요 없이 먹어도 설사·발진 같은 부작용은 올 수 있습니다.

RESISTANCE
내성만 남깁니다
몸속 세균이 약에 잘 안 듣게 변하고, 몇 달 남기도 합니다.

SAVE IT
폐렴 때 쓸 약을 아낍니다
정말 세균 감염이 왔을 때 잘 듣도록 아껴 둡니다.

항생제가 필요한지는 진찰로 판단합니다



부비동(코 옆 빈 공간)에 액체가 고인 모습

이럴 때	진찰에서 보는 점
코 증상이 오래 갈 때	코막힘·콧물·후비루(Postnasal drip)가 **10일 넘게 좋아지지 않거나, 좋아지다가 다시 나빠질 때** — 콧물 색만으로 정하지 않습니다
얼굴 통증	광대·눈 주위 통증·압박감 — 부비동염(Sinusitis) 의심. 부비동 안에 액체가 고이면 압박감·통증·코막힘이 오래 갈 수 있습니다
청진 이상	폐렴(Pneumonia) 등 세균 감염이 의심되는 소리가 나면 흉부 X선 등으로 더 확인합니다 — 청진 소리만으로 항생제를 정하지 않습니다
세균성 인후염	검사로 확인된 경우

증상 하나로 정하지 않습니다 — 기간·중증도·재악화를 함께 봅니다. 단순 기관지염은 대개 항생제 없이 낫습니다.

합병증 없는 부비동염은 진료 후 증상치료하며 경과를 볼 수 있습니다.
아산 28회 연수강좌 — 부비동염과 알레르기 비염 진단과 치료 전략(권혁수)

쓸 때는 끝까지 — 항생제와 감기약은 끊는 법이 다릅니다

구분	항생제(Antibiotics) · 세균을 없애는 약	감기약·소염제 · 증상을 덜어 주는 약
좋아지면?	**좋아져도 처방받은 기간대로 드세요.** 임의로 줄이거나 끊지 말고 먼저 상의해 주세요	좋아지면 먼저 끊어도 됩니다
불편하면?	설사는 끊기 전에 먼저 연락 주세요. 새 발진·두드러기가 생기면 다음 복용 전 즉시 의료진에게 문의하세요. 단, 숨이 차거나 입술·혀가 붓거나 물집 생긴 발진은 **바로 끊고 응급실로**. 남은 약은 다음 감기에 먹지 않습니다	줄이거나 끊고, 진료 때 말씀해 주세요

수액 · IV FLUIDS

탈수·설사·구토로 못 드실 때 — 수분·전해질을 채워 회복에 큰 도움이 됩니다

감기로 지쳤을 때 — 잘 못 드시고 기운이 떨어지면 수분·전해질과 함께 비타민을 보충하는 수액을 진료에서 선택할 수 있습니다

회복을 돕는 보조 치료로, 감기를 직접 낫게 하는 치료제는 아닙니다

실손 보험 — 감기·영양 수액은 인정되지 않을 수 있습니다. 보장은 약관에 따라 달라 접수에서 안내해 드립니다

자주 듣는 말	실제로는
"항생제를 먹어야 빨리 낫는다"	감기는 항생제로 빨리 낫지 않고, 부작용과 내성만 남습니다
"지난번처럼 항생제 넣어 달라"	지난번엔 저절로 낫는 시기와 겹친 것입니다. 이번은 이번 진찰로 봅니다
"피곤하면 수액만 맞으면 된다"	피로가 오래가면 간수치·갑상선 기능·빈혈·염증 수치 등 내과 문제부터 확인합니다. 비타민 수액은 일부 피로에 도움이 될 수 있어, 신장질환·결석 병력 등 몸 상태를 살펴 성분·용량을 정합니다

감기약을 먹는 중에 이러면 다시 진료를 받으세요

FEVER
열이 이어질 때
38.5°C 이상 열이 지속되거나 3~4일 넘게 이어질 때, 열이 내렸다가 다시 오를 때

WORSENING
좋아지다 다시 나빠질 때
좋아지다가 열·기침이 다시 나빠지거나, 1주 넘게 뚜렷한 호전이 없을 때

COUGH · SPUTUM
기침·가래가 심해질 때
진한 가래가 늘거나 가래 때문에 잠을 못 잘 때 — 색보다 양·냄새·피 섞임·기간을 봅니다

FLUIDS
물을 잘 못 마실 때
물을 잘 못 마셔 소변이 줄면 당일 내원하세요

다시 오시면 체온·산소포화도·청진으로 확인하고, 필요하면 흉부 X선·독감/코로나 검사·혈액검사를 합니다. 갑자기 열이 나면 **「열이 나면 — 독감·코로나 검사는 언제 받나요?」** 안내문을, 숨이 차면 **뒷면의 '숨이 찰 때' 표**를 보세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560 · 평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — CDC Common Cold 2026 · CDC Sinus Infection 2024 · ACP·CDC 2016 · Cochrane 2025(감기)·2021(인후통) · BMJ 2010(내성) · AAO-HNS 성인 부비동염 지침 2015 · NICE CG174

본 자료는 감기에 항생제·수액을 쓰는 원칙과 다시 진료가 필요한 신호를 안내하는 일반 자료입니다. 나이·임신 여부·면역상태·기저질환에 따라 더 빠른 진료가 필요할 수 있습니다.

감기 뒤 기침이 오래 갈 때

감기를 앓고 나면 기관지가 예민해져 기침이 몇 주 동안 이어질 수 있습니다.

감기 뒤 기침, 왜 오래갈까요

기관지가 예민해진 상태 · AIRWAY SENSITIVITY

감기 후 2주가 넘도록 기침이 이어지는 경우가 있습니다. 감염을 앓으며 기관지가 예민해진 상태이기 때문입니다. **나아진 것 같아도 며칠은 운동·산책을 미루고 찬바람을 피하세요.** 기관지는 파도를 막는 방파제와 같아서, 걸렸다 나았다를 반복하면 방파제가 점점 약해집니다.

헛기침이 기침을 부르는 악순환 · COUGH CYCLE

헛기침을 할 때마다 목에 상처가 나서 기침이 길어집니다. 참을 수 있는 기침은 참고, 사탕·껌·미지근한 물을 활용하세요. **가래를 일부러 긁어 올려 뱉지 마세요** — 기관지에 상처가 나 기침이 더 심해지고, 가래에 피가 섞이기도 합니다.

기간별로 보는 기침 경과와 대처

구분	기간	대개의 경과	할 일 및 권장 대처
급성 기침	**3주 미만**	감기 등 급성 상기도 감염이 대부분입니다.	충분한 휴식과 수분 섭취, 대증 치료를 합니다.
아급성 기침	**3~8주**	감기 뒤 기침은 대개 여기 속하고 저절로 좋아지는 경우가 많습니다.	진료로 확인했고 좋아지는 중이면 헛기침을 줄이고 참을 수 있는 기침은 참으며 기다립니다.
만성 기침	**8주 이상**	특정 원인 질환이 있을 수 있습니다.	**원인을 찾는 정밀 검사**가 필요합니다.

오래 가는 기침의 흔한 원인

오래 가는 기침은 비염(후비루)·천식(기침형 천식)·역류성 식도염이 흔한 원인입니다. 원인에 따라 코 스프레이·흡입제·식도염 약을 사용합니다.

구분	주요 특징 및 치료
비염·부비동염 (후비루)	**콧물이 목 뒤로 넘어가 기침을 유발할 수 있습니다.** 코 스프레이 사용법은 **알러지 비염 코 스프레이 사용법** 안내문을 참고하세요.
천식 (기침형 천식)	기침형 천식을 포함한 천식으로 기침이 지속될 수 있으며, 필요 시 흡입제 치료를 상의합니다.
역류성 식도염	속쓰림·신물 같은 증상이 함께 있다면 역류가 기침과 관련될 수 있어 식도염 약을 사용합니다.
복용 약물 (혈압약 등)	혈압약 중 ACE 억제제(이름이 '-프릴'로 끝나는 약)는 마른기침을 일으킬 수 있습니다 — 복용 중이면 진료 때 알려 주세요.



물 자주 마시기와 실내 습도 관리

생활 관리 · LIFESTYLE

담배는 기침을 오래 끌게 합니다. 금연하고 간접흡연을 피하세요. 물을 자주 마시고 실내가 너무 건조하지 않게 관리하세요.

매일 쓰는 흡입기라면

흡입기는 증상이 없어도 매일 씁니다. 임의로 중단하지 마세요. 사용법은 **심비코트 라피헬러 흡입기 사용법** 안내문을 참고하세요.

흔한 오해 · FAQ

✕ "3~8주 기침이면 또 검사해야 한다"

이미 진찰·흉부 사진으로 확인했고 좋아지는 중이면 같은 검사를 반복할 필요는 없습니다. 기침이 2주를 넘었는데 아직 결핵 확인(흉부 사진 등)을 받지 않았다면, 전에 진료를 받았더라도 다시 진료를 받으세요.

✕ "흡입기는 불편할 때만 쓴다"

매일 쓰도록 처방된 흡입기는 증상이 없는 날에도 꾸준히 사용합니다.

숨이 찰 때·위험 신호 — 감기 중에도, 감기 뒤에도 같은 기준입니다

당일 진료	바로 응급실	119
• **숨참 없이 쌕쌕거림만** 새로 생길 때 • 흉부 답답함·흉통이 생긴 경우 • **가래에 피가 섞일 때** — 기침 기간과 관계없이 • 열이 나거나 진한 가래가 늘 때 — 엑스레이로 확인	• **숨이 차는 증상이 새로 생길 때** — 기침 기간과 관계없이 • 숨이 차지 않아도 호흡이 빨라질 때 • 피를 많이 뱉을 때 • 천식·COPD(만성폐쇄성폐질환)·심부전이 있는데 호흡이 나빠질 때 • 침도 못 삼킬 만큼 목이 아프거나 눈 주위 붓기·심한 두통 • 소변이 거의 안 나오는 심한 탈수 • 심한 어지럼이 있거나 크게 처질 때	• **말하기 힘들 만큼 숨이 찰 때**, 입술·얼굴이 파래질 때 • 가슴 통증·압박감이 계속되거나 식은땀이 날 때 • 의식이 흐리거나 깨우기 어려울 때, 실신

기침이 **8주를 넘기거나** 체중감소·식은땀이 함께 있으면 원인을 찾는 검사를 합니다.

진료실 설명 자료 — 감염 후 기침을 그림으로 설명한 슬라이드: edu.gwanggyobarun.com/decks/pulmo/post-infectious-cough/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국내 개정 기침 진료지침 2020 · 대한천식알레르기학회 만성기침 진료지침 2018 · ERS 기침 가이드라인 2020 · GINA 천식 관리 지침 2026 · 결핵 진료지침 2024 · CDC Flu Warning Signs 2024

본 자료는 감기 뒤 기침이 오래 갈 때 참고할 일반 안내이며, 개인의 나이·기저질환·동반 증상에 따라 진료 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/cold-and-cough/